

EVCP — 2017

Annales officielles EVC
Médecine générale

bjbj

MEDECINE GENERALE Epreuve de vérification des connaissances pratiques TOUS LES SUJETS SONT A TRAITER Sujet

1 Patient de 65 ans, retraité depuis quelques mois. Antécédents et facteurs de risque : surpoids, IMC à 29, tabagisme à 25 paquets/années interrompu il y a 10 ans, HTA traitée par Prazosine. La famille l'amène aux urgences car lors petit déjeuner (90 minutes plus tôt), il a présenté des troubles de l'élocution et a lâché son bol. Vous constatez qu'il est hémi-parétique à droite et aphasique. Question N

1 Quel diagnostic évoquez-vous en premier

? Question N

2 Quel examen complémentaire faut-il réaliser ? Question N

3 En l'

absence d

hémorragie, quelle stratégie de prise en charge proposez-vous

4 La pression artérielle est alors à 155/85 mm Hg

: que faites-vous

5 Pourquoi faut-il réaliser un ECG

6 Comment le résultat (de l'

ECG) peut-il orienter votre prise en charge

? Question N

7 Vous le revoyez en consultation un mois plus tard. Il a toujours le même traitement. Sa pression artérielle est à 155/85 (confirmée par auto-mesures). Que proposez-vous

TSVP Sujet

2 Vous recevez aux Urgences Mr G, 85 ans, adressé pour chute au domicile. Son aide ménagère a appelé les pompiers en le découvrant au sol dans ses toilettes, ce matin, Constantes à l'arrivée

: TA 105/65 mmHg , pouls 110 BPM, température auriculaire 37,5

, Saturation 92% (air ambiant). Il est désorienté sans signe méningé ni de localisation neurologique. L

électro-cardiogramme est normal hormis une tachycardie sinusale. Vous contactez son médecin traitant qui vous détaille ses antécédents

: Ethylo- tabagisme chronique

HTA- Dépression Ainsi que ses traitements

: Perindopril 4mg/j - Nicardipine 50 mg/12H

Hydrochlorothiazide 25mg/j (ajout récent en raison d

une HTA insuffisamment contrôlée.) Paroxétine 20mg/j

Bromazepam 6mg/j

Aspirine 75MG/J Question N

1 Quelles sont les 3 principales causes de chute à évoquer chez ce patient? Question N

2 Il n

a pas pu se relever seul. Vous notez une ecchymose frontale et il ressent une douleur fessière.

Quel (s) examen (s) d

imagerie demandez-vous

? Justifiez. Question N

3 Le patient continue à présenter des troubles cognitifs malgré la normalité des examens d

imagerie. Suggérez 2 éléments à vérifier à l

examen clinique. Question N

4 Voici ses premiers résultats biologiques

: Leucocytes $9,8 \times 10^9/L$ - Hémoglobine $9,4 g/dl$

VGM $75 fl$ Globules rouges $3,5.10^{12}/L$

Plaquettes $350.10^9/L$

Sodium $120 mmol$ Potassium $4,8 mmol$

Chlore $87 mmol$

Bicarbonates $24 mmol$

Urée $15 mmol$

Créatinine 212

Glucose $5,5 mmol$

Calcium $2,2 mmol$

Protides $65 g/L$

CPK $5200 U/L$. Quelles anomalies significatives identifiez vous

TSVP Question N

5 Quelles sont les causes possibles de l

anomalie du ionogramme sanguin

6 Le patient est hospitalisé en service de médecine pour rééquilibration hydro- électrolytique .

Quelle (s) classe (s) médicamenteuse (s) utilisez vous pour l

anti coagulation prophylactique

7 Après 3 jours d

hospitalisation, l

infirmière vous signale avoir découvert un méléna dans le lit du patient. A la gastroscopie, quelles sont les 3 anomalies que vous vous attendez à observer de façon la plus probable

? Sujet

3 Un homme de 70 ans se plaint d

une douleur d

apparition brutale de la base thoracique gauche associée à une dyspnée. Dans les antécédents on note une hypertension artérielle bien équilibrée sous amlodipine, une diabète de type 2 traité par sulfamides hypoglycémiantes,

un polype colique réséqué et une gonarthrose. Il existe un tabagisme actif. L

examen clinique montre une température à $38,0$

C, une fréquence cardiaque régulière à $95/min$, une saturation en oxygène au doigt à 92% (en air ambiant) et une tension artérielle à $154/91 mmHg$. Question N

1 Quelles sont les 3 hypothèses diagnostiques que vous devez évoquer

2 Dans l

hypothèse d

une embolie pulmonaire, quel examen permet de confirmer ce diagnostic

embolie pulmonaire est confirmée. Quel bilan pré-thérapeutique prescrivez-vous

TSVP Question N

4 Dans l

hypothèse où le bilan pré- thérapeutique est normal, quel type de traitement anticoagulant prescrivez-vous d

emblée ? Question N

5 Dans l

hypothèse où l

hémogramme montre un taux d

hémoglobine de 9,7 g/dl avec un VGM à 74 fl. Quels éléments d

interrogatoire cherchez-vous compte tenu de ce résultat

6 Dans ce contexte d

anémie microcytaire, quel est le diagnostic le plus probable

? Quel examen demandez-vous pour le confirmer

? Sujet

4 Un homme de 45 ans est amené aux urgences par les pompiers suite à une chute sur la voie publique. Il présente une plaie du scalp. On note plusieurs passages aux urgences cette année dans des circonstances identiques. Il a comme ATCD des séjours en hospitalisation psychiatrique et un traitement injectable retard mensuel haloperidol* 4 ampoules, administré en centre médico psychologique. Il est actuellement au chômage. Il vit en foyer d

hébergement d

urgence. A son arrivée, on retrouve une plaie du cuir chevelu de 5 cm

; il est logorrhéique, et tient des propos familiers. La pression artérielle est de 130/80 mm, le pouls est à 90/min. la température à 37,6. La saturation en oxygène de 96%. L

éthylomètre pratiqué est de 0.8 en air expiré. Question N

: Six heures après son admission aux urgences, l

infirmière vous appelle pour une crise convulsive, en phase de récupération. A ce stade, que demandez-vous comme investigations indispensables sachant que votre examen clinique est normal

TSVP Question N

: Les examens complémentaires sont normaux. Quelques heures plus tard, le patient s agite, hurle, dit qu

il voit son chien aboyer dans la pièce et qu

il faut lui donner à manger. La température est de 38

6, le pouls à 120 min, la tension artérielle à 180/120. L

examen clinique est toujours sans particularités. Quels sont les principaux diagnostics à poser

: Que prescrivez-vous comme traitement en première intention

: Le diagnostic de Gayet Wernicke est posé chez ce patient dans les suites de l

hospitalisation Quelles sont les trois principaux signes cliniques qui évoquent ce diagnostic

? Question N

: Quel est le traitement à préconiser

dans le syndrome de Gayet Wernicke

? Question N

: a/ En l

absence de traitement, quelle peut être l

évolution à terme de ce syndrome

? b/ Quels en sont les trois principaux signes cliniques

FILENAME \p

[illegible]